

Relaksacja stosowana *Öst*

Systematyczne skracanie relaksacji: od 15 minut do 30 sekund „na żądanie” w sytuacji lękowej.

CZAS: 15 min dziennie × 8 tyg. Codziennie, bez przerw

ŹRÓDŁO: Öst (1987); Öst & Westling (1995, RCT N=38); NICE CG113

JAK UŻYWAĆ

Przejdź **7 faz** protokołu przez 8 tygodni, jedna faza tygodniowo. Każda faza skraca i upraszcza technikę: od pełnej progresywnej relaksacji mięśni Jacobsona (15 min) do szybkiej 30-sekundowej sekwencji w sytuacji lękowej. **Nie pomijaj faz** — pominięcie skracania (próba stosowania pełnej relaksacji „w sytuacji”) daje zerową skuteczność.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Klasyczna progresywna relaksacja mięśni (ang. *progressive muscle relaxation*, PMR) Jacobsona (1938) wymaga 15–20 minut w spokojnym miejscu — w realnej sytuacji lękowej (transport, sklep, praca) bezużyteczna. Öst (Uniwersytet w Uppsali) rozwinął protokół skracania do 30 s „na żądanie”. Öst i Westling (1995, randomizowane badanie kliniczne N=38): **porównywalna skuteczność do terapii poznawczej** w panice. NICE CG113 wymienia ją wśród dowodowych technik leczenia. Mechanizm: nawyk szybkiej relaksacji uwarunkowany słowem-kluczem działa *odruchowo*.

01 Siedem faz protokołu — 8 tygodni

TYDZIEŃ	FAZA · CZAS DZIENNY	CO KONKRETNIE ROBIĆ	CEL FAZY
1–2	Pełna PMR 2 × 15 min/dzień	16 grup mięśniowych: dłonie → przedramiona → ramiona → barki → szyja → twarz → klatka → brzuch → pośladki → uda → łydki → stopy. Napinaj 5 s, rozluźniaj 15 s.	Poznać każdą grupę. Zauważyć kontrast napięcie ↔ rozluźnienie.
3–4	Skrócona PMR 2 × 7 min/dzień	7 grup mięśniowych — łącz: obie ręce razem, twarz jako całość, nogi jako całość. Ta sama sekwencja napięcie-rozluźnienie.	Przyspieszyć relaksację. Utrzymać efekt mimo skrócenia.
5	Tylko rozluźnianie 2 × 5 min/dzień	Pomijasz napinanie. Skanujesz kolejne grupy mięśni, świadomie je rozluźniasz „od środka”.	Relaksacja bez fizycznego napinania — krok ku „mentalnej”.
6	Relaksacja warunkowa 2 × 2 min/dzień	Słowo-klucz („spokój”, „luz”) wymawiane w myśli na wydechu, kojarzone z rozluźnieniem całego ciała.	Warunkowanie: słowo → odruchowe rozluźnienie.
7	Szybka relaksacja 15–20 × 30 s/dzień	30 s w neutralnych sytuacjach codziennych: w kolejce, na światłach, przed snem, po obudzeniu. Wydech + słowo + rozluźnienie.	Wytrenować technikę w prawdziwym życiu, nie tylko na kanapie.
8+	Pod lękiem w razie potrzeby	Przy pierwszych objawach ataku — 30-sekundowa sekwencja: wydech + słowo-klucz + skanowanie i rozluźnienie. <i>Bez przerywania aktywności.</i>	Aplikacja kliniczna — narzędzie „na żądanie”.

02 ✕ Cztery pułapki, które rujnują protokół

BŁĄD 1 · POMINIĘCIE SKRACANIA

Próba stosowania pełnej PMR w sytuacji lękowej — nie działa. W metrze nie da się napiąć 16 grup mięśni. Cały sekret protokołu to *stopniowe* skracanie.

BŁĄD 2 · PRZERWY W PRAKTYCE

„Codziennie” znaczy codziennie — 7 dni w tygodniu przez 8 tyg. Pominięcie 2–3 dni wymaga powtórzenia ostatniej fazy. To budowanie nawyku, nie kursu.

BŁĄD 3 · POŚPIECH DO FAZY 7

Aplikacja w sytuacji lękowej za wcześnie. Öst (1987): pacjenci, którzy doszli tylko do fazy 3–4, nie uzyskiwali efektu klinicznego. Pełne 8 tyg. albo nic.

BŁĄD 4 · RELAKSACJA JAKO RATUNEK

„Tylko relaksacja mnie uratuje” — pułapka. Jak każda technika somatyczna, może stać się *zachowaniem zabezpieczającym* blokującym ekspozycję interoceptywną. Stosuj świadomie, nie magicznie.

03 📅 Dziennik 8 tygodni

Po każdym tygodniu zapisz: ile sesji udało się wykonać, średnią ocenę napięcia 0–10 PRZED i PO sesji, liczbę zastosowań w ciągu dnia (od tyg. 7).

TYG.	FAZA	SESJI W TYG.	NAPIĘCIE PRZED	NAPIĘCIE PO	ZASTOSOWAŃ CODZIENNIE	UWAGI
1	Pełna PMR 16 grup, 15 min					
2	Pełna PMR 16 grup, 15 min					
3	Skrócona PMR 7 grup, 7 min					
4	Skrócona PMR 7 grup, 7 min					
5	Tylko rozluźnianie 5 min					
6	Warunkowa ze słowem-kluczem 2 min					
7	Szybka 30 s × 15–20/dzień					
8	Aplikacja w lęku — w razie potrzeby					

Klucz: Öst (1987) podkreślał, że efekt wynika z **umiejętności**, nie z relaksacji jako stanu. Cel: nie „być rozluźnionym”, lecz *umieć rozluźnić się w 30 s, gdziekolwiek jesteś*. To narzędzie behawioralne — kompletnie niezależne od pracy poznawczej, więc dobrze łączy się z każdą inną techniką. Najlepsza alternatywa dla pacjentów, dla których terapia poznawcza nie jest preferowana.